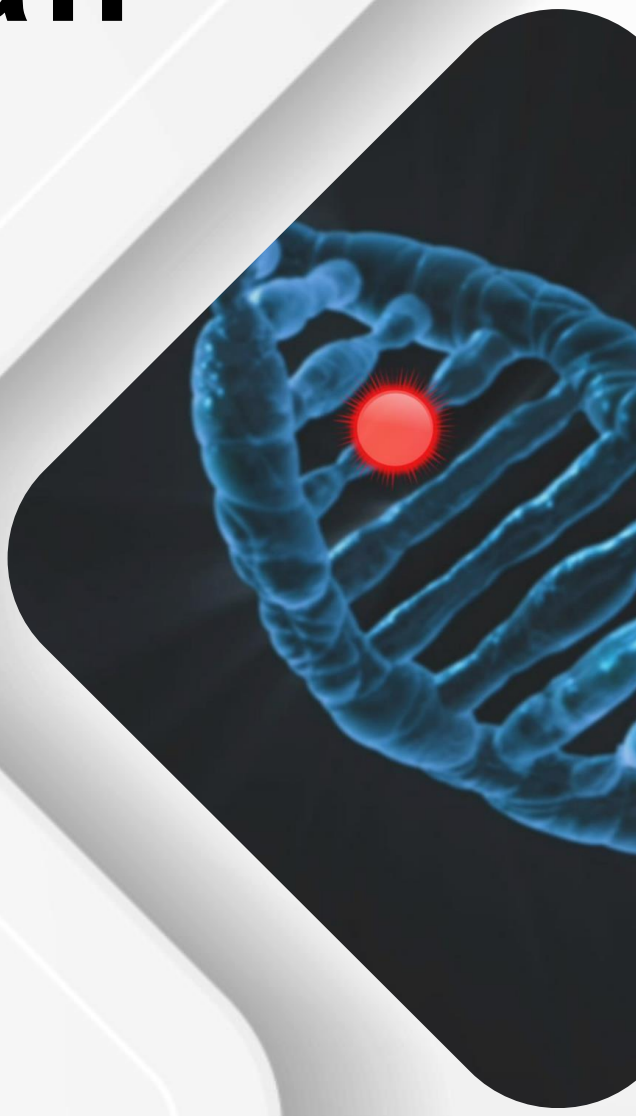
Kemenkes
RSJPD Harapan Kita

Hasil Pemeriksaan Genomik

RS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

Jl. Letjen S. Parman No.87, Kota Bambu Utara, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11420



Kemenkes
RSJPD Harapan Kita

Unit Laboratorium Molekular dan Stem Cell Facilities
Instalasi Penelitian dan Pengembangan
RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
Telp : 568 1111, 568 4085 - 568 4093
Email: biomol.scf@pjnhk.go.id

Informasi Pasien

Nama lengkap :_____

Tanggal lahir :_____

Usia :_____

Jenis kelamin :_____

Berat badan :_____kg

Tinggi badan :_____cm

No rekam medis:_____

Informasi Sampel

Dokter pengirim :_____

Tipe spesimen :_____

Pemeriksaan : ☐ APOE ☐ SLCO1B1

Waktu pengambilan :_____

Waktu penerimaan :_____

Informasi Klinis

Diagnosa :

Faktor Risiko PJK

- ☐ Diabetes Militus
- ☐ Hipertensi
- ☐ Dislipidemia
- ☐ Perokok Aktif
- ☐ Perokok Pasif
- ☐ PJK keluarga usia muda

Kondisi klinis :

Obat Statin yang Rutin Dikonsumsi

Jenis statin	Dosis	Frekuensi	Durasi
☐ Atorvastatin	_____	_____	_____
☐ Lovastatin	_____	_____	_____
☐ Pitavastatin	_____	_____	_____
☐ Pravastatin	_____	_____	_____
☐ Rosuvastatin	_____	_____	_____
☐ Simvastatin	_____	_____	_____

Laporan ini hanya untuk keperluan penelitian.

Hasil Pemeriksaan Genetik

Gen Uji	Fenotipe	Genotipe	Diplotipe
SLCO1B1			
APOE			

Hasil Pemeriksaan Lain

1. Tekanan darah (sistolik/diastolik) = _____ / _____ mmHg
2. Kolesterol total = _____ mg/dL
3. Kolesterol HDL = _____ mg/dL
4. Kolesterol LDL = _____ mg/dL
5. Trigliseria = _____ mg/dL

Kesimpulan dan Tindak Lanjut

Kesimpulan :

Tindak Lanjut Pengobatan :

Laporan ini hanya untuk keperluan penelitian.

Metode Uji

Informasi Tambahan

1. *Melakukan tes untuk kondisi genetik merupakan hal yang kompleks. Kami merekomendasikan untuk menjalani konsultasi dengan profesional sebelum Anda memberikan persetujan dan sesudah menjalani tes untuk memahami secara lengkap resiko dan manfaat dari melakukan tes, serta tindak lanjut yang diperlukan setelah menerima hasil.*
2. *Karena keterbatasan teknologi dan kurangnya basis pengetahuan terkait gen, beberapa perubahan dalam DNA atau produk protein yang dapat menyebabkan penyakit mungkin tidak terdeteksi oleh tes.*
3. *Terdapat kemungkinan bahwa hasil temuan laboratorium tidak dapat diinterpretasikan atau kurang signifikansinya. Dalam situasi tertentu, hasil temuan mungkin menunjukkan suatu kondisi yang berbeda dari diagnosis yang semula dipertimbangkan.*
4. *Tes yang ditawarkan dianggap yang terbaik yang tersedia saat ini. Seluruh penafsiran, penilaian, dan/atau analisis informasi didasarkan pada pengetahuan yang berlaku dan standar serta praktik yang dapat diterima pada saat itu, namun tidak terbatas pada literatur medis dan basis data ilmiah dan/atau pedoman klinis.*
5. *Pengujian ini bersifat kompleks dan menggunakan bahan/reagen khusus. Kami mengambil setiap tindakan pencegahan dan kontrol dalam tiap tahap pemrosesan spesimen, akan tetapi, masih memungkinkan terdapat ketidaksesuaian.*
6. *Pengujian molekuler dapat mendeteksi perubahan DNA (mutasi). Umumnya, tes molekuler sangat sensitif dan spesifik; namun, hal tersebut tergantung pada karakteristik tiap gen dan metodolgi tes. Untuk beberapa kelainan genetik, metode biokimia terkadang digunakan untuk melihat kelainan pada produk protein yang diproduksi oleh gen mutan.*
7. *Interpretasi yang akurat dari hasil tes DNA berdasarkan pada informasi akurat yang diberikan individu yang melakukan tes genetik dan/atau dokter yang merawat, termasuk diagnosa klinis, pengobatan sebelumnya, riwayat keluarga, dan informasi lain yang diberikan dalam formulir pemesanan.*
8. *Diagnosis klinis yang keliru pada anggota keluarga dapat menyebabkan hasil diagnosis yang keliru juga untuk anggota keluarganya yang lain.*
9. *Rekomendasi yang disampaikan mungkin tidak akurat atau tidak sesuai untuk individu yang menderita autoimun, hepatitis, dan riwayat transplantasi hati.*
10. *Hasil pemeriksaan genetik diinterpretasikan sesuai dengan kondisi spesimen, informasi klinis dan riwayat keluarga. Jika informasi yang diberikan tidak akurat atau tidak memadai, hasil tes dapat menghasilkan data yang kurang optimal*
11. *Interpretasi varian yang berasal dari basis data didasarkan pada informasi ilmiah, medis, dan teknologi terkini, sehingga klasifikasi varian dapat mengalami perubahan*

Sumber